

Equivalencias orientativas de antihipertensivos

Ficha rápida para consulta. Adultos. Hipertensión esencial. Dosis por vía oral salvo que se indique lo contrario. Revisado: julio 2026.

Idea clave: entre familias distintas no existe una conversión mg-a-mg fiable. Las tablas sirven para sustitución aproximada dentro de la misma familia y para estimar dosis baja/media/alta. Ajustar siempre a respuesta tensional, tolerancia, función renal, potasio, edad, fragilidad, embarazo, IC, cardiopatía isquémica, albuminuria y comorbilidades.

Cómo usar la tabla

1. Cambios dentro de la misma familia: elegir la columna de potencia aproximada equivalente y reevaluar PA, creatinina/eGFR y K+ cuando proceda.
2. Cambios entre familias: no convertir “equivalente”; iniciar dosis baja o media según PA y riesgo, y titular.
3. En ancianos, fragilidad, depleción de volumen, ERC avanzada o combinación con diuréticos: empezar bajo y revisar pronto.
4. IECA y ARA-II no deben combinarse de rutina por mayor riesgo renal/hiperpotasemia sin beneficio clínico neto en HTA común.

Equivalencia clínica entre grupos: regla práctica

Situación	Cambio razonable	Comentario práctico
IECA -> ARA-II	Cambiar a dosis comparable baja/media/alta del ARA-II	Útil por tos con IECA. Mantener vigilancia renal y K+.
ARA-II -> IECA	Cambiar a dosis comparable baja/media/alta del IECA	Evitar si antecedente de angioedema.
IECA/ARA-II -> calcioantagonista DHP	No hay equivalencia directa	Amlodipino 5 mg suele ser dosis media; 10 mg alta. Vigilar edema maleolar.
IECA/ARA-II o DHP -> tiazida/tiazídico-like	No hay equivalencia directa	Indapamida SR 1.5 mg o clortalidona 12.5 mg suelen ser dosis iniciales eficaces. Vigilar Na+, K+, urato, eGFR.
Betabloqueante -> otro betabloqueante	Usar tabla de dosis baja/media/alta	No retirar bruscamente si cardiopatía isquémica o taquiarritmia.
Cualquier monoterapia insuficiente	Preferible combinar clases antes que forzar dosis máxima	Combinaciones frecuentes: IECA/ARA-II + DHP; IECA/ARA-II + tiazídico-like; triple: RAS + DHP + tiazídico-like.

1. IECA - equivalencias aproximadas

Referencia mental útil: ramipril 2.5 mg ~= enalapril 5 mg ~= lisinopril 10 mg como potencia aproximada inicial/intermedia baja. La respuesta individual varía.

Fármaco	Dosis baja aproximada	Dosis media aproximada	Dosis alta aproximada	Dosis máxima habitual HTA	Notas
Ramipril	1.25-2.5 mg/24 h	5 mg/24 h	10 mg/24 h	10-20 mg/día según ficha/protocolo	Muy usado; titular lento en ERC/anciano.
Enalapril	5 mg/24 h	10-20 mg/día	20-40 mg/día	40 mg/día	Puede dividirse cada 12 h.
Lisinopril	10 mg/24 h	20 mg/24 h	40 mg/24 h	40 mg/día	Vida media larga.
Perindopril	4 mg/24 h	5-8 mg/24 h	8-10 mg/24 h	8-10 mg/día según sal	Ojo a equivalencia por sal arginina/erbumina.
Captopril	12.5-25 mg/8-12 h	25-50 mg/8-12 h	50 mg/8 h	150-200 mg/día	Corta duración; útil cuando se busca titulación rápida, no ideal crónico.

Precauciones IECA/ARA-II: embarazo contraindicado; revisar creatinina/eGFR y potasio tras inicio o subida, especialmente en ERC, ancianos, diuréticos, AINE, espironolactona o deshidratación.

2. ARA-II - equivalencias aproximadas

Fármaco	Dosis baja	Dosis media	Dosis alta	Máxima habitual	Notas
Losartán	25 mg/24 h	50 mg/24 h	100 mg/24 h	100 mg/día	Puede requerir 50 mg/12 h en algunos pacientes.
Valsartán	80 mg/24 h	160 mg/24 h	320 mg/24 h	320 mg/día	Frecuente en combinaciones.
Candesartán	8 mg/24 h	16 mg/24 h	32 mg/24 h	32 mg/día	Potente; buena opción si precisa control sostenido.
Irbesartán	75 mg/24 h	150 mg/24 h	300 mg/24 h	300 mg/día	Útil en nefroprotección diabética según indicación.
Olmesartán	10 mg/24 h	20 mg/24 h	40 mg/24 h	40 mg/día	Vigilar enteropatía rara tipo sprue.
Telmisartán	20 mg/24 h	40 mg/24 h	80 mg/24 h	80 mg/día	Vida media larga.
Azilsartán	20 mg/24 h	40 mg/24 h	80 mg/24 h	80 mg/día	No siempre disponible/financiado igual.

3. Calcioantagonistas

Grupo/fármaco	Dosis baja	Dosis media	Dosis alta	Notas útiles
Amlodipino (DHP)	2.5 mg/24 h	5 mg/24 h	10 mg/24 h	Edema maleolar dosis-dependiente; no corregir con diurético si es puro edema vasodilatador.
Lercanidipino (DHP)	10 mg/24 h	10-20 mg/24 h	20 mg/24 h	Menos edema en algunos pacientes; tomar antes de comida.
Felodipino retard (DHP)	2.5 mg/24 h	5 mg/24 h	10 mg/24 h	No triturar formas retard.
Nifedipino GITS/retard (DHP)	30 mg/24 h	60 mg/24 h	90-120 mg/24 h	Evitar formulaciones de liberación inmediata para HTA crónica.
Diltiazem retard (no DHP)	120 mg/24 h	180-240 mg/24 h	300-360 mg/24 h	Bradicardia/bloqueo AV; cuidado con betabloqueantes.
Verapamilo retard (no DHP)	120 mg/24 h	180-240 mg/24 h	360-480 mg/24 h	Estreñimiento; evitar en IC-FER y bloqueo AV.

4. Diuréticos tiazídicos y tiazídico-like

Fármaco	Dosis baja	Dosis media/alta	Máxima habitual HTA	Comentarios
Hidroclorotiazida	12.5 mg/24 h	25 mg/24 h	25-50 mg/día	Menos potente y menos duradera que clortalidona/indapamida; 50 mg aumenta toxicidad.
Clortalidona	12.5 mg/24 h	25 mg/24 h	25 mg/día	Más potente/larga; más hipopotasemia e hiponatremia.
Indapamida SR	1.5 mg/24 h	-	1.5 mg/día	Equivale clínicamente a indapamida IR 2.5 mg aprox.
Indapamida IR	1.25 mg/24 h	2.5 mg/24 h	2.5 mg/día	Buena evidencia en HTA; controlar Na/K.
Furosemida	20-40 mg/día	40-80 mg/día o más	Variable	No es antihipertensivo de primera línea salvo ERC avanzada/edema/IC. Duración corta.

Análítica: Na⁺, K⁺, creatinina/eGFR y ácido úrico. Mayor riesgo de hiponatremia en mujeres mayores, bajo peso, ingesta baja de sal, ISRS y polifarmacia.

5. Betabloqueantes - equivalencias orientativas

En HTA no complicada no suelen ser primera elección salvo indicación: cardiopatía isquémica, post-IAM, IC, control de frecuencia, migraña, temblor, hipertiroidismo, etc.

Fármaco	Dosis baja	Dosis media	Dosis alta	Notas
Bisoprolol	1.25-2.5 mg/24 h	5 mg/24 h	10 mg/24 h	Cardioselectivo; ajustar en bradicardia.
Atenolol	25 mg/24 h	50 mg/24 h	100 mg/24 h	Renal; menos preferido en muchas guías modernas.
Metoprolol succinato	25-50 mg/24 h	100 mg/24 h	200 mg/24 h	Retard; no confundir con tartrato.
Nebivolol	2.5 mg/24 h	5 mg/24 h	10 mg/24 h	Cardioselectivo; perfil vasodilatador.
Carvedilol	6.25 mg/12 h	12.5 mg/12 h	25 mg/12 h	Alfa/beta; más hipotensión ortostática.
Propranolol	10-40 mg/8-12 h	40-80 mg/12 h	160-320 mg/día	No selectivo; útil en temblor/migraña/hipertiroidismo.

6. Otros antihipertensivos habituales

Grupo/fármaco	Dosis inicial habitual	Rango habitual	Puntos de seguridad
Espironolactona	12.5-25 mg/24 h	25-50 mg/24 h	4º fármaco típico en HTA resistente si K+ y eGFR lo permiten. Vigilar hiperK, ginecomastia.
Eplerenona	25 mg/24 h	25-50 mg/12-24 h	Menos efectos antiandrogénicos; vigilar K+.
Doxazosina GITS	4 mg noche	4-8 mg/24 h	Útil si HBP; hipotensión ortostática.
Moxonidina	0.2 mg/24 h	0.2-0.4 mg/24 h	Sequedad boca, somnolencia; no retirar bruscamente.
Hidralazina	25 mg/8-12 h	50-100 mg/8 h	Taquicardia/edema; uso seleccionado.
Minoxidil	2.5-5 mg/24 h	5-40 mg/día	Resistente grave; requiere diurético de asa y beta-bloqueo. Hipertriosis.

Combinaciones y algoritmo práctico

Escenario	Opción preferente	Evitar / cuidado
HTA esencial de inicio, la mayoría	IECA o ARA-II + calcioantagonista DHP o tiazídico-like, a dosis bajas-medias	Monoterapia en PA muy elevada suele quedarse corta.
Diabetes/albuminuria/ERC con albuminuria	IECA o ARA-II como base, titular a dosis tolerada	No combinar IECA + ARA-II. Vigilar K+/eGFR.
Edema con amlodipino	Reducir dosis, cambiar DHP o asociar IECA/ARA-II si no lo llevaba	No asumir que furosemida lo arregla.
HTA resistente confirmada	Triple: IECA/ARA-II + DHP + tiazídico-like; añadir espironolactona si apto	Descartar mala técnica, bata blanca, AINE, alcohol, apnea sueño, adherencia.
Anciano frágil/ortostatismo	Dosis bajas, objetivos individualizados, medir bipedestación	Sobrediuresis, alfa-bloqueantes nocturnos, bajadas bruscas.
Urgencia hipertensiva sin daño órgano diana	Tratamiento oral, descenso gradual en 24-48 h	No bajar rápido con nifedipino sublingual ni bolos agresivos.

Resumen ultra-rápido de equivalencias internas

Familia	Baja	Media	Alta
IECA	Ramipril 2.5 / Enalapril 5 / Lisinopril 10	Ramipril 5 / Enalapril 10-20 / Lisinopril 20	Ramipril 10 / Enalapril 20-40 / Lisinopril 40
ARA-II	Losartán 25 / Valsartán 80 / Candesartán 8	Losartán 50 / Valsartán 160 / Candesartán 16	Losartán 100 / Valsartán 320 / Candesartán 32
DHP	Amlodipino 2.5 / Lercanidipino 10	Amlodipino 5 / Lercanidipino 10-20	Amlodipino 10 / Lercanidipino 20
Tiazidas-like	Clortalidona 12.5 / Indapamida SR 1.5	Clortalidona 25 / Indapamida IR 2.5	No forzar mucho más: más toxicidad que beneficio
Beta-bloq.	Bisoprolol 2.5 / Atenolol 25 / Nebivolol 2.5	Bisoprolol 5 / Atenolol 50 / Nebivolol 5	Bisoprolol 10 / Atenolol 100 / Nebivolol 10

Fuentes y notas

- ESC Guidelines 2024 for the management of elevated blood pressure and hypertension: recomiendan estrategias combinadas y tratamiento por clases farmacológicas de primera línea.
- British & Irish Hypertension Society: material educativo por clases de antihipertensivos.
- UCSF Hospital Handbook: tabla de conversión aproximada de IECA.
- MedSask/recursos farmacoterapéuticos de comparación ARA-II: equivalencias estimadas; monitorizar tras cambio.
- Ficha técnica/local formulary: confirmar presentaciones, dosis máximas y financiación en España.

Este documento no sustituye la ficha técnica ni el juicio clínico. En embarazo, hiperpotasemia, ERC avanzada, estenosis bilateral de arteria renal, síncope/ortostatismo, IC-FEr, FA, cardiopatía isquémica o daño agudo de órgano diana, individualizar.